

2026년 6차 약제급여평가위원회 사전 검토 보고

심평원 공식 보도자료 기반 한국 신약 reimbursement pipeline 현황과 6/4 회의 전망

회의	약제급여평가위원회 2026년 제6차
일자	2026-06-04 (목)
직전 차수	2026-05-07 제5차 약평위
직전 암질심	2026-05-27 제5차 암질심
위원회 인선	10기 약평위 (2025-09 출범, 위원 74명 중 30명 유임·44명 신규)
정부 측 인사	2026-05-18 강준혁 신임 보건약제과장 부임 — 본 회의가 첫 정기 의결 회의

들어가며

본 보고서는 심사평가원이 공식적으로 공개하는 보도자료를 1차 권위 source로 사용하고, 매체 보도는 통과·미통과의 사유와 맥락 분석에만 활용한다. 매체 보도가 통과 약물 list나 차수 표기에서 부정확한 사례가 다수 확인됐기 때문이다. 예를 들어 한 주요 매체는 5/7 5차 약평위 통과 약물을 "폴라이비·예스카타 2종"으로 보도했으나, 심평원 공식 보도자료는 결정신청 4종(보신티·보노칸·보노엠·브레즈트리) + 신약 승인 2종(예스카타·레테브모) + RSA 확대 1종(티센트릭) + 재심의 1종(리브리반트)을 명시한다. 5/7 약평위에서 가장 중요한 결정 사항인 리브리반트 재심의는 어느 매체 보도에서도 강조되지 않았다.

본 6/4 6차 약평위에 대한 전망과 후속 신약 등재 환경 분석을 다음과 같이 정리한다.

1. 5/7 5차 약평위 — 정확한 결과 (심평원 공식 기준)

심평원 공식 보도자료(brdBltno=11793)에 따르면 본 차수는 세 가지 트랙으로 운영됐다.

트랙 A — 결정신청 약제 (5건)

#	약물	회사	적응증	결과
1	보신티정 (보노프라잔푸마르산염)	한국다케다	위궤양 등	통과
2	보노칸정 (보노프라잔토실산염)	경보제약	위궤양 등	통과
3	보노엠정 (보노프라잔토실산염)	마더스제약	위궤양 등	통과
4	브레즈트리에어로스피어흡입제	한국아스트라제네카	COPD 유지	통과
5	리브리반트주 (아미반타말)	한국얀센	비소세포폐암	재심의 ★

트랙 B — 신약 승인 (2건)

#	약물	회사	적응증
1	에스카타주 (CAR-T)	길리어드코리아	림프종
2	레테브모캡슐 (셀퍼카티닙)	한국릴리	폐암·갑상선수질암

트랙 C — 위험분담계약 약제 (1건)

약물	회사	적응증
티센트릭주 (아테졸리주맙)	한국로슈	NSCLC 급여범위 확대 (RSA)

핵심 관찰

- **보노프라잔 P-CAB 계열 3종 동시 통과**: 다케다 보신티·경보 보노칸·마더스 보노엠 — 동일 성분 제네릭 시장 본격 형성 신호
- **리브리반트(EGFR+ NSCLC) 재심의** ☆ : 한국얀센 리브리반트는 2022·2023·2024·2025년 암질심 4회 미설정 후 자진취하·재신청 트랙을 거쳐 2026-05-07 약평위 첫 진입에서 재심의 결정. 한국 reimbursement pipeline에서 가장 오래 등재 trajectory를 거친 약물 중 하나

2. 5/27 5차 암질심 — 정확한 결과 (심평원 공식 기준)

심평원 공식 보도자료(brdBltno=11808) 기준 본 차수는 신약 5종을 심의했다.

통과 (급여기준 설정) — 2종

약물	회사	적응증
엘라히어주 (mirvetuximab)	한국애브비	FRα+ 백금저항성 난소암 등
버제니오정 (abemaciclib)	한국릴리	HR+/HER2- 조기 유방암 보조

미통과 (급여기준 미설정) — 3종

약물	회사	적응증
림카토주 (CAR-T)	(주)큐로셀	r/r DLBCL CAR-T (국산 1호)
알레센자캡슐 (알렉티닙)	한국로슈	ALK+ NSCLC 보조요법
키스칼리정 (리보시클립)	한국노바티스	HR+/HER2- 조기 유방암 보조

차수 numbering 정정 사항

심평원 공식 보도자료는 본 차수를 **"제5차"**로 표기. 일부 한국 의약 전문지가 "4차"로 표기한 사례가 있으나, 심평원 공식이 단독 권위. 본 보고서 이후 5/27 = 5차, 7/8 = 6차로 통일.

3. 6/4 6차 약평위 안건 후보 — pipeline 추적 기반 ☆

본 회의에 대한 직접 안건 사전 보도는 어떤 매체에서도 식별되지 않는다. 단 심평원 공식 보도자료에서 확인된 직전 결정 사항과 1년 누적 추적 데이터를 통해 다음 약물들이 잠재적 안건 후보로 분류된다.

후보 Tier 1 — 매우 가능성 ↑ (재상정·재진입 패턴)

약물	회사	직전 status	적용 룰	후보 사유
리브리 반트주	한국 안센	2026-05-07 5차 약평위 재심의	PR-004 (재심 의→재상정)	한국 약평위의 통상 패턴은 재심의 → 다음 차수 보완 자료 검토 → 재 상정. 5/7 재심의로부터 4주 경과한 6/4 시점에 재진입 가능성 ↑

후보 Tier 2 — 가능성 medium (4개월 이상 약평위 미진입)

다음 4종은 2026-01-21 1차 암질심 통과 후 약 4.5개월 약평위 미진입 상태. 회사·심평원 사후 협의 완료 시 6/4 또는 7/2 차수 진입 가능성.

약물	회사	적응증	암질심 통과 후 경과
자카비 (록소리티닙)	노바티스	진성철혈구증가증 확대	4.5개월
카보메틱스	입센·HK이노엔	신장세포암 단독 확대	4.5개월
사이람자 (라무시루맙)	한국릴리	위암 단독·병용 확대	4.5개월
포말리스트 (포말리도마이드)	한국BMS	다발골수종 병용 (1차 + 4/15 4차 추가 등장)	4.5개월

후보 Tier 3 — 가능성 lower (최근 통과, 통상 1~3개월 lag 필요)

약물	회사	직전 status	가능성
옵디보+여보이 (1차 간세포암)	한국오 노/BMS	2026-04-15 4차 암질심 통과	7주 경과 — 7/2 가능성 ↑
엘라히어 (난소암)	한국애브비	2026-05-27 5차 암질심 통과 + PR-001 적용	김민정 사무관 5/12 fast-track 발언 — 7/2 가능성 ↑
버제니오 (조기 유방암)	한국릴리	2026-05-27 5차 암질심 통과	7/2 또는 8/6 가능성

그 외 — 정기 운영 안건

10기 위원회 + 5/18 신임 보편약제과장 부임 직후 첫 정기 회의로서 다음 운영 안건 가능성: - 약가재평가·기등재 인하 - 사용량-약가 연동 협상 결과 검토 - 면역항암제 선별집중심사 운영 중간 점검 (2026/1/1 시행 후 5개월 경과)

4. 한국 신약 reimbursement pipeline — 본 시점 trends

4-1. "부결"이 아닌 "재심의" 후 재상정 구조

심평원 공식 보도자료 12개월 추적 결과 명시적 "부결" 결정은 거의 없고, 대부분 "재심의" 형식으로 결정 유보 후 다음 차수 재상정 패턴이 확인됐다. 회사 측 자료 보완 신속성에 따라 turnaround는 1~9개월 폭으로 다양:

- 가장 빠른 case: 과지바 — 1차수 skip 후 다음 차수 통과 (약 1개월)
- 표준 case: 임핀지·이뮤도 (담도암·간세포암 1차) — 2025-9차 재심의 → 2025-11차 통과 (약 2개월)
- 느린 case: 다잘렉스 적응증 확대 — 9개월 후 통과

4-2. RSA·조건부 통과 비중 상승

직전 4차·5차 약평위 통과 약물 중 위험분담제 적용 또는 "평가금액 이하 수용 시" 조건부 결정 비중이 절반 수준: - 4차: 베오바·엘루시렘 조건부 / 블린사이토 RSA 확대 = 3/6 - 5차: 리브리반트 재심의 / 티센트릭 RSA 확대 / 에스카타 신약 트랙 = 3/8

순수 무조건 통과는 점차 줄어드는 추세. NHIS 재정 부담 관리 강화 + 회사 측 가격 양보 결합 패턴이 자리잡았다.

4-3. 7~9월 등재 timeline 집중

직전 4차·5차 약평위 통과 약물 13종이 모두 NHIS 약가협상 단계 진입 중이며 7~9월 등재 timeline에 집중. NHIS 약가협상부 처리 capacity 한계가 후속 신약 등재 지연 가능성 시그널.

4-4. CAR-T 등재 환경의 두 갈래

같은 r/r DLBCL CAR-T 영역에서 글로벌 자산(에스카타·길리어드)이 5차 약평위 신약 승인 트랙 통과한 반면, 국산 1호(림카토·큐로셀)는 5차 암질심에서 미설정. 에스카타 NHIS 협상 결과가 후속 CAR-T 등재 reference price 환경 형성의 시발점. 후속 국산 ATMP 등재 timing 가정 보수적 재검토 필요.

4-5. 면역항암제 정책 환경의 분기점

2026/1/1 키트루다 11개 적응증 일괄 확대 + 면역항암제 선별집중심사 신규 지정이 동시 발효된 정책 패키지로, 적응증 확대 기회와 사용량 관리 압박이 양립하는 환경. H2 후반 첫 운영 결과 가시화 시 후속 적응증 신청·기존 RSA 재협상 환경에 직접 영향.

4-6. 임상 OS 진성성이 결정 변수

5/27 5차 암질심에서 ESMO 2025 monarchE 7년 OS 데이터를 추가한 버제니오가 통과한 반면, 같은 차수에 같은 적응증으로 도전한 키스칼리(NATALEE OS 미성숙)는 미설정. 동일 클래스 약물이 동일 차수에 다룰 때 OS 우위 약물만 통과한다는 패턴이 11기 위원회 첫 사례로 형성됐다. 후속 신청 약물의 임상 데이터 패키지 — PFS·DFS 단독으로는 부족 — 점검 필요.

4-7. 정부 D-14 발언의 신호 정량성 (PR-001 등록)

엘라히어 통과는 김민정 보권약제과 사무관 5/12 토론회 "5월 안으로 적극 검토" 발언과 시점적으로 정확히 일치. 차수 약 2주 전 정부 사무관·국과장 차원의 명시적 약물 거명이 통과와 강한 상관 관계. 본 패턴은 본 시스템 예측률 PR-001로 등록됐고, 후속 차수 D-14 시점 모니터링 기준으로 활용된다.

본 보고는 6/4 회의 D-2 시점 사전 예측. D+1(6/5) 시점에 심평원 공식 보도자료가 발표되면 본 예측과 실제 결과를 자동 비교(audit)해 예측률(PR-001~005·PR-101~104)의 weight를 보정하고 신규 패턴이 발견되면 후보 룰로 등록한다. 차수가 누적될수록 예측 정확도가 자동으로 향상되도록 시스템이 구성됐다.